

양방진단학 SUMMARY 공지사항

- 피피티와 프린트로 수업을 진행하셨습니다만 그냥 쓱 훑는 느낌으로 보시면서 첨언 정도 하셨습니다.

- 해당 써머리는 선배 써머리에 교수님이 언급하신 내용을 추가했습니다.

양방진단학 SUMMARY 사용법

- 중요해 보이는 내용은 가독성을 위해 **굵은 글씨**와 **빨간 글씨**, **파란 글씨**로 표시하겠습니다.(이번에 추가된 내용은 **진한 파란 글씨**)

[복부의 진찰]

- 병원에 오면 가장 겁나는 경우는 숨 가쁘다고 할 때, 밤에(저녁 9시-새벽 6시) 배 아프다고 할 때이다.

1. Equipment of Physical exam

1) 기구 및 준비물품: 청진기, 센티미터 줄자, 표시용 펜 (마커펜)

* 좋은 불빛과 조용한 분위기

2) 검진자

① 따뜻한 손과 짧은 손톱

② Hand washing

③ 천천히, 부드럽게, 급격한 움직임은 No!

④ 환자에게 불편한 곳이나 통증이 있는 곳 질문

⑤ 대상자 오른쪽에 서서 검사 시작

⑥ 아픈 부위는 가장 마지막에 검사

3) 대상자

① bladder prep

② 복부의 완전한 노출이완

③ Supine position

④ Both arms at the sides

⑤ 작은 베개 (머리와 무릎아래)

⑥ 복부근육을 충분히 이완

⑦ 천천히 구강 호흡하도록

⑧ Relaxed patient

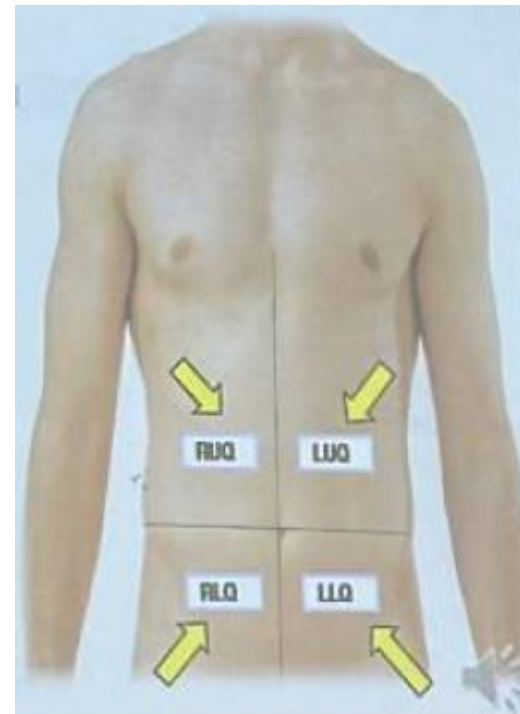
2. Think anatomically (landmarks)

1) 복부 4 분역 - Four quadrants system

① **RUQ**: liver, GB(담낭), pylorus(유문부), duodenum(십이지장), pancreas(췌장) head Rt adrenal gland, Rt kidney portion, hepatic flexure of colon, **A-colon & T-colon** portion

② **LUQ**: Lt liver lobe, spleen, stomach, Lt adrenal gland, **pancreas body**, splenic flexure of colon, T-colon & D-colon portion

③ **RLQ**: Rt kidney lower pole, **cecum(맹장)** & appendix, A-colon portion, Rt **ureter**, bladder(팽창시) ovary & salpinx, uterus (확대시)



④ **LLQ**: Lt kidney lower pole, S-colon, D-colon portion, Lt ureter, bladder(팽창시) **ovary & salpinx uterus** (확대시) Lt spermatic cord

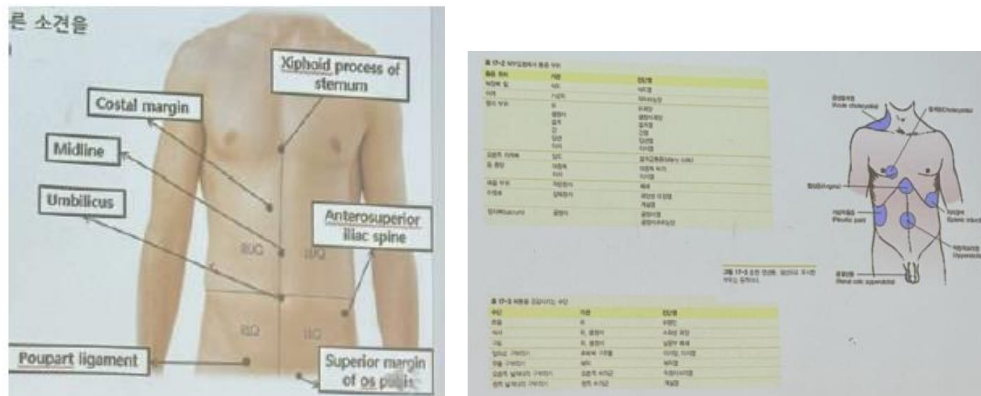
- 우상복부: 중요한 장기 有. (대개 복부는 오른쪽이 중요. 왼쪽은 큰 문제 안 일으킨다.)

- 오른쪽이 아프다 하면 그 부분 장기가 대강 어느 것인지 알아두어야 함.

2) 복부 7분역 (seven quadrants system)

① pain. Tenderness의 위치 및 다른 소견을 기술하는 데 유용한 landmarks

② 흉골의 검상돌기, 늑골변연, 중앙선, 배꼽, 전상 장골극, 서혜인대, 치골상연



3. Physical examination technique

: Inspection 시진, Auscultation 청진, Percussion 타진, Palpation 촉진

* **복부 검진: 시-청-타-촉진 순서로 진행 (기타 검진: 시-촉-타-청 순서)**

- 복부: 시진 다음에는 청진하는 습관 들이기 (타진을 먼저 하거나 하면 소리가 달라질 수 있기 때문)

4. Inspection 사진

1) 방법

① 대상자가 방광을 비운 후, 바로 누운 자세에서 팔을 옆에 두도록 한다.

② 대상자의 오른쪽에 서서 빛을 비스듬히 비추고, 복부와 같은 눈 높이에서 복부 사진

③ 당신이 무엇을 수행하고 있는 것인지 천천히 그리고 신중하게 설명하고 환자에게 접근

- 방광이 차 있으면 통증이 다양하게 느껴지는 경우가 있으므로 비우고 오라고 해야함

- 오른쪽 아프면 맹장을 의심할 수 있으며, 외쪽 아프면 계실염을 의심할 수 있다.

- 복부 진단의 순서는 시진, 청진, 타진, 촉진 순서로 진행한다. (기타 부위는 시진, 촉진, 타진, 청진 순이 기본)

- 복부 진단을 받기 전에는 소변을 보고 오는 것이 좋으며,

- 머리를 약간 앞으로 숙이게 해서 복직근을 이완시켜야 진단하기 편하다.

2) 복부표면 특징



① 피부색: 다른 부위와 비슷하거나 다소 연한 색

② 복부 표면의 특징: 두드러진 정맥혈관의 양상이나 병터가 없어야 하며, 반흔이나 선이 있는지 주목

③ 반흔: 기록하고 그것의 위치, 모양, 상대적인 크기를 복부에 그린다.
(내부유착 가능성)

④ 비정상적인 소견을 발견했다면 그 위치를 사분역 내에서 파악

3) 복부의 시진

- ① 복부의 윤곽 시진: 평평하거나 둥글거나 오목
- ② 배꼽 시진: 중앙에 위치, 약간 돌출되어보일 수 있다
- ③ 대상자의 머리 뒤에 서서 대칭성 유무 확인
- ④ 복부는 팽만하거나 돌출되지 않아야 한다.
- ⑤ 복부는 덩어리가 발견되지 않고, 근육의 통합성 유지

4) 이상 소견

: 감추어진 이상 소견을 발견하기 위해서는 다음의 2가지 간단한 방법을 사용

① "숨을 깊이 쉬고 잠시 동안 참아보세요."

: 횡격막을 아래로 내리고 복강 내 장기를 눌러서 이전에 보이지 않던 돌출이나, 종괴를 볼 수 있게 한다.

② "이제 편하게 숨을 쉬면서 머리를 들어올리세요."

: 복직근을 수축시키고 표층의 복벽을 볼 수 있게 해준다. 만약 탈장이 있다면 복압을 증가시켜 탈장이 돌출된다.

- 편하게 숨쉬고 머리를 올리면(위몸 일으키기 하듯) 복벽이 긴장하면서 복벽 아래 종괴 등은 보기 힘들어지는 대신 복벽 위(피부 밑)를 확인 가능

5) 운동 상태

- ① 복부운동: 부드럽고 호흡과 함께 규칙적으로 일어난다.
- ② 남자 - 복식호흡, 여성 - 흉식호흡 (주로 한다)
- ③ 이때 복부의 표면이나 상복부 중앙선에서 눈에 띄게 두드러지는 박동 증상이 없어야한다.

6) 쿨렌 징후 (Cullen sign)

① 제부 주위에 반상출혈 (Ecchymosis)

② 질병: 복강내 출혈, 자궁외 임신의 파열, 출혈성 췌장염

- 복강 내 출혈이 있어서 흡수되면서 피하로 모이는 것으로 배꼽 주위 멍든 것처럼 출혈이 나타남

- 배꼽 주위 멍 = 복강 내 출혈

- 질병: 복강 내 출혈을 일으키는 혈관 파열, tumor / 자궁 외 임신 / 출혈성 췌장염(시간이 지나면 조직, 혈관 괴사) 등



7) 터너 징후 (Grey Turner sign)

① 측복부에 반상출혈 (Ecchymosis)

② 질병: 복강내출혈, 출혈성 췌장염

- 신장이나 복강 내 가해진 손상으로 생긴 출혈이 피하로 와서 멍든 것처럼 보임

- 뚝 떨어지거나 교통사고 일어난 경우에도 가능



8) IVC obstruction

① Lower abdominal veins reverse flow and flow to the lower pressure SVC system (upper abdomen and chest)

② Condition can cause ascites and be confused with cirrhosis.

- IVC(하대정맥) 폐쇄 (사진 상 왼쪽)

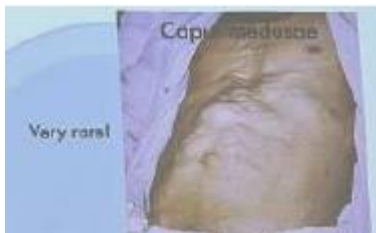
- tumor 침범, 혈관 내 혈액이 고이거나 엉키고, 외부에서 누르는 등 이유로 위에서 막히면 혈액이 올라가지 못해서 혈관이 두껍고 확장

- 질병: 다른 질환보다 thyrosis, 간내 종양 등 생각해봐야 함

9) case

① Outward flow pattern from umbilicus in all directions?

② 하대정맥의 협착, 폐색 또는 간경변 등으로 인한 문맥계의 순환장애



(Portal HTN)

- 제부 위쪽으로 울룩불룩

- 문맥압 항진 시 대표적 현상 (문맥압 항진 시 간 속으로 들어가는 혈관

들이 다 저항을 받아서 배꼽 주변 혈관들이 두꺼워지고 확장된다. 배꼽뿐 아니라 하부식도, 측부순환 정맥 등도 확장이 되지만 눈으로 볼 수 있는 건 배꼽 주위)

- 대표적 질환: 간경변, 간암 등

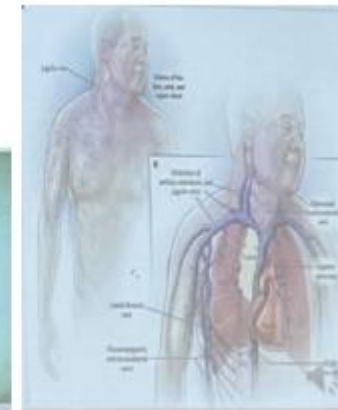
10) SVC obstruction (상대정맥 폐쇄)

① Higher pressure will cause upper abdominal veins to flow towards the umbilicus to escape into the IVC system.

② Veins of **neck, chest, and arms** also dilate.

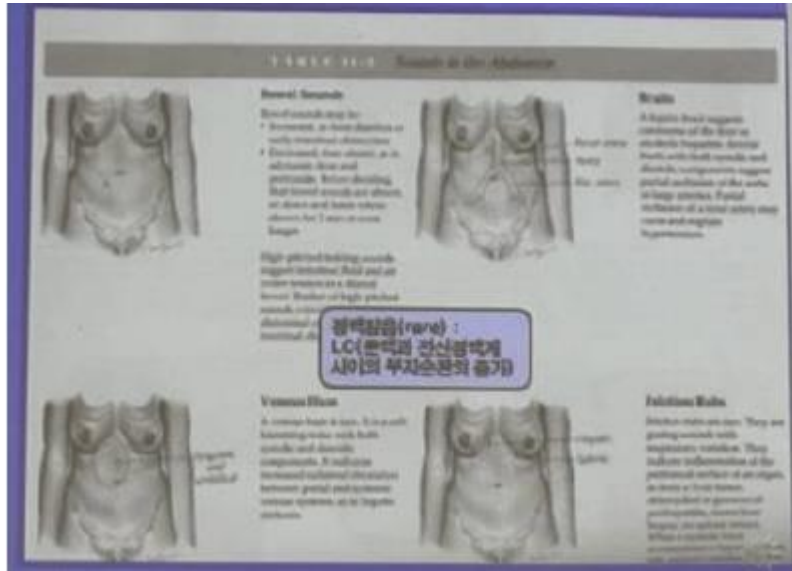
- 복막강 아래로는 큰 이상이 없고 상체 쪽 이상 (어깨, 목 등 혈관 돌출)

- 우심방으로 상대정맥이 열리는데 그게 압박 등으로 못 열리게 되면 그 위에 있는 혈관들이 다 커지는 것



5. Auscultation 청진

- ① 장음 (Bowel sounds)
- ② 혈관음 (Vascular sounds, Bruits, HUM)
- ③ 마찰음 (Friction Rubs)



- 우리는 장음을 듣는 게 중요
- 장음(Bowel sounds), 혈관음(Vascular sounds, Bruits, HUM), 마찰음(Friction Rubs)
 - 흙은 정맥에서 나는 소리, 마찰음은 크게 의미 없음
 - 장음: 처음으로 청진기의 종으로 된 부위로 듣는다. 장 소리가 있으면서 설사가 있는 것은 문제가 되지 않지만 변비가 있는 경우는 문제가 될 수 있다.
 - 고음조(복통)은 초기 장폐색, 장음 감소는 복막염과 마비성 장폐쇄를 고려(통증 때문에 장 운동의 줄어듦 or 종양이나 담석 등으로 인해 기계적으로 마비)
 - Bruits: 소리가 나는데 혈압이 높은 경우 문제가 될 수 있다.
 - HUM: 혈관 분포가 많은 부위에서 발생하기에 간암, 간종양 등을 의심할 수 있다.
 - Rubs: 크게 의미 없다.

1) 장음 청진법

- ① 복부를 검진할 때는 시진 후에 청진
- ② 타진과 촉진은 창자소리의 빈도와 강도에 변화를 줄 수 있다.
- ③ 막형 청진기 (diaphragm)를 따뜻하게 하여 사용
- ④ 대략 1cm 깊이로 누르면서 청진
- ⑤ '딸깍' 소리와 '꼬르륵' 소리는 꿈틀운동이 일어나고 있다는 것을 의미하며, 이는 **1분에 5~30회** 정도로 불규칙하게 일어난다.

- 1분 정도 좀 길게 들어야 함

- 5회 밑 장음 감소, 30회 이상 장음 항진

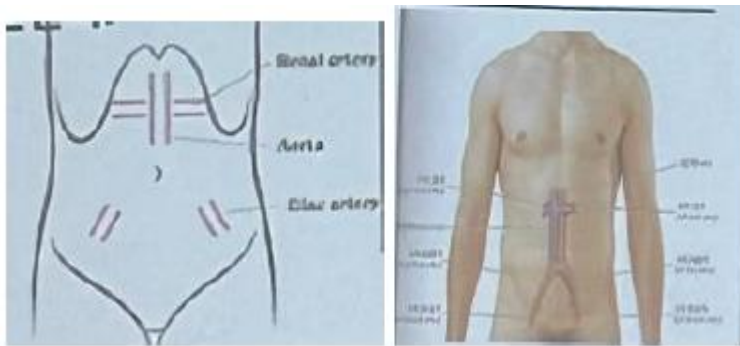
2) 장음 Q. 정상 장음과 비정상 장음 (12)

- ① 고음조(복통): 초기 장폐색
- ② 장음 증가: diarrhea, early intestinal obstruction을 고려
- ③ 장음 감소: 복막염과 마비성 장폐쇄
- ④ 적어도 2~5분간은 들어보기
 - 장폐색: 초기 장폐색 때는 장음 증가 (막힌 장을 통과해서 빠져나가야 하니까) -> 나중에는 안 들림
 - 마비성 장폐쇄: 장이 거의 안 움직임. (원인-전해질 불균형, 척수 손상 등)

3) 혈관음 듣는 법

- ① 청진기의 종형으로 심와부에서 듣기
- ② 각각의 사분역에서 대동맥, 신동맥, 장골동맥, 그리고 대퇴동맥에서의 수축기 잡음을 듣는다.
 - 대동맥: 제일 많이 듣는 곳. 체중이 많이 나가는 사람은 잘 안들림.
 - 배꼽 상부에서 수축기 때 씨익씨익 혈관이 통하는 소리
 - 잘 안 들리던 부위에서 동맥에서 나는 소리가 들리면 좁아졌구나 (작은 관을 높은 압력이 빠지면 고음이 나게되므로, 대표적으로 서혜부)
 - 신동맥: 드물게 청년 고혈압이 있는 사람

- 일반적인 고혈압은 본태성 (원인 모르는 systemic한 문제)
- But 이렇게 복강 내 한쪽(배꼽 위 상복부, 심와부)에서 소리 나는 경우: 신동맥 폐쇄로 소리가 나는 것
- 소리 나는 사람이 혈압이 높으면 신동맥 폐쇄로 인한 것이군
- 혈압이 높은 청장년 층에서는 복벽에 청진기를 대고 신동맥 상태를 확인해보자



4) 혈관음

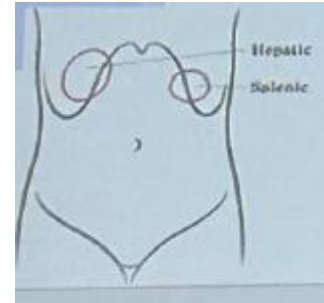
- ① 동맥의 부분적 폐쇄로 혈류의 와류가 형성되면서 나는 심잡음과 유사한 소리
- ② 고혈압 환자에서 epigastric bruits가 들리고 측면으로 방사 → renal artery stenosis 의심
- ③ 하지의 arterial insufficiency가 의심 → aorta, iliac artery, femoral artery 등의 주행경로 위에 청진기를 대고 bruits 확인

4) 마찰음 - (간, 비장) rare

Rubs:

- ① 청진기의 판막형으로 간과 비장 위에서 듣는다. (양쪽 상복부)
- ② 고음조이며 호흡과 연관
- ③ 드물긴 하지만 종양, 감염(급성 담낭염) 또는 경색된 장기의 복막표

면의 염증 시사



- 마찰음은 비비는 소리(비닐을 비비는 소리)로 염증이 생긴 복막 등이 다른 곳과 부딪히면서 나는 소리임
- 늑골 궁에서 잘 들림
- 드물다, 이것을 Rub이라고 한다, 마찰음.

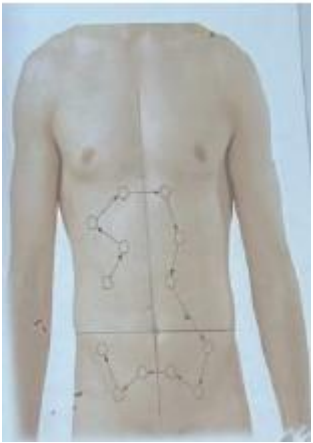
6. Percussion 타진: Liver, Spleen

1) Technique

- ① Both light and heavy percussion are needed on the abdomen.
- ② Light can be done with fingers, heavy may require the blunt end of the reflex hammer as the plexor.
- ③ DIP joint (distal interphalangeal)
 - 왼손을 피부에 대고 오른손 중지를 이용해서 지지대로 삼아서 타진 (호흡기 시간하고 같은 방법)
 - 예전에는 복수 환자도 한의원에 많이 왔었다. 요즘은 근골격계와 같은 1차 진료를 많이 하지만 이건 진정한 한의사가 아니다.
 - 진정한 한의사는 내과 질환을 볼 수 있고, 변증, 처방 구성을 할 줄 알아야 한다.

2) 타진

- ① 복부 내 장기의 크기와 농도 평가
- ② 체액(복수), 공기(위 팽만: 고장음) 또는 고형 종괴의 존재를 찾기 위해 사용
- ③ 둔탁음: 간과 같은 고형의 장기, 팽만된 방광과 덩어리에서 들릴 수 있다.
- ④ 노인: 노화로 인한 장운동의 감소로 가스가 차서 가스팽만음이 더 크게 들리거나 넓은 범위에서 들릴 수 있다.



- 사진의 순서대로 한다.
- 할 때는 shape을 그리거나 좌우를 비교해서 하는 게 좋음

3) 복부의 타진 음색

- 과도공명음: 위와 폐가 좀 붙어있어서 접경 지역에서 공명음보다 좀 높은 소리. 특히 위에 공기가 많이 있을 때.
- 탁음: 간, 콩팥, 임신, 자궁근종

4) 간의 크기

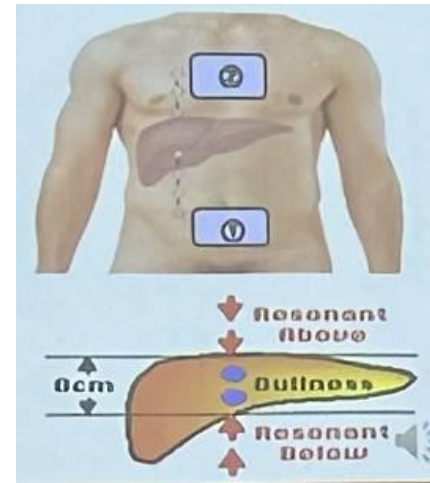
- ① 간의 크기를 확인하기 위해 타진
- ② 항상 고장음의 영역부터 시작해서 탁음의 영역으로 진행 (소리의 변

화를 확인 용이)

- ③ 간의 크기는 대개 6~12cm 정도
- ④ 노인: 간의 크기가 조금 작고, 1~2cm 정도 아래에 위치

음색	기술	위치
고장음	공명음보다 고음조의 음악적 음색	가스가 찬 내장
과도공명음	고음과 공명음의 사이의 음조	좌측 폐의 기저부
공명음	중간음조의 일정한 음색	폐 및 간혹 복부 위
탁음	공명음이 거의 없는 짧고 높은 음조의 음색	공기가 찬 구조와 인접한 고형성 장기 위

- 지방간, 간경변 등 의심 시 간 크기 확인하려고 한의원에서 많이 씀
- 타진을 위아래서 resonance로 해오다 보면 어느 순간 dullness 소리가 들림 -> 그 시점을 표시하면 간의 크기 (아래 사진 참고)
- 대개 8cm~12cm면 정상. 12cm 넘으면 비대. 너무 작으면 내가 잘못 측정했는지 생각해보거나 아니면 줄어드는 경우도 있음
- 노인에서는 폐가 계속 기능을 하다가 못하게 돼서 공기가 차 있게 되어서 밑으로 내려오게 된다.



5) 비장

- ① 좌측에서 중앙액와선의 바로 뒤쪽 10번째 늑골 변을 타진
- ② 비장박음의 작은 부위는 6~10번째 늑골
- ③ 박음 부위가 커지면 비장종대 또는 위팽만과 대변으로 인한 박음과 구별 필요

- 사실 비장 타진은 잘 안 씀. 왜냐면 사실 비장은 만져보면 안다. 많이 커진 사람은 잡아보면 비장 종대가 잡힘.



- 비장종대의 원인
 - 간 종대: 가장 큰 이유. Portal vein에 고혈압이 있거나 하면 그쪽으로 가던 피들이 못 가서 비장으로 흘러서 비장이 점차 커진다.
 - 혈액질환들(혈액암, 백혈병): 성숙되지 않은 혈구들을 비장이 파괴해야 하니까 비장이 커짐.
 - 비장종대는 간경변, 혈액질환에서 흔히 볼 수 있음

6) 신장

- ① Sitting position
- ② 검진자의 손바닥을 늑골척추각 부위에 놓고, 반대쪽 손은 주먹을 쥐고 손등 위를 두드립니다.

③ 왼쪽에서 반복

- ④ 타격을 느끼지만 그 자체로 압통의 통증이 유발되서는 안 된다.

7) 신장통증을 위한 늑척추각의 주먹타진

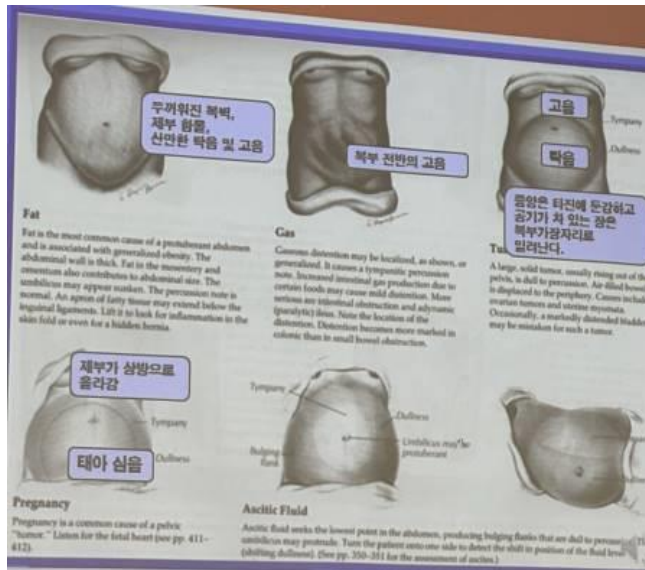
(아래 사진 왼쪽 - 간접 타진 / 오른쪽 - 직접타진)

- 신장 병변이 있어서 타진하는 것 X. 비뇨기계 감염 감별.
- 요통이 심하다고 하면서 열 난다고 하면 비뇨기계 감염도 의심 -> 단순 허리 통증과 감별하는 방법이 주먹 타진. 소변검사, 혈액검사 등 하기 전에 시행
- 한손으로 탁탁 두드리는데 두드릴 때마다 한쪽이 아픔 (반대는 괜찮다 함) + 그러면서 열이 난다 = 콩팥 감염, 급성 신우신염.
- 간접타진은 손 하나 대고, 직접타진은 가볍게 그냥 때리는 거



8) 복부 타진의 감별

- 첫번째 그림: Fat(비만) = 두꺼워진 복벽, 제부함몰, 산만한 탁음 및 고음
- 두번째 그림: gas = 살은 없는데 복부 전반의 고음



- 세번째 그림: 복강 내 종양 = 위는 고음 아래는 탁음 + 배 모양이 이상 (종양은 타진에 둔감하고 공기가 차 있는 장은 복부 가장자리로 밀려남)
- 네번째 그림: 임신 = 제부가 상방으로 올라감, 태아 심음

7. Palpation 촉진

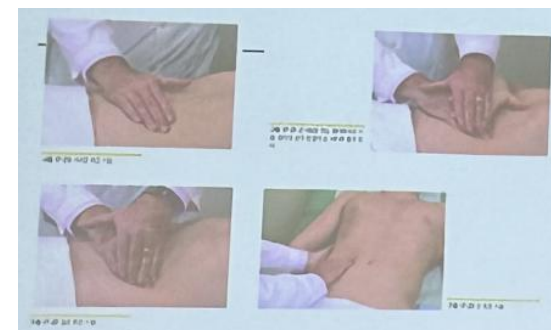
- 촉진의 경우, 안쪽의 무언가가 큰 경우에는 뭐가 밑에 있구나하고 만져짐 (구별까지 안되는데)



1) 촉진

- ① 복강 내의 장기를 평가하고 근육경련, 종괴, 액체 그리고 압통부위를 찾는 데 사용
- ② 복부 장기는 크기, 모양, 이동성, 복근의 경도와 긴장도 평가
- ③ 대상자의 우측에 서서 시행
- ④ 대상자가 무릎을 구부리는 것은 근육이완에 도움
- ⑤ 손을 따뜻하게: 근육 수축 방지

Q. 복부 촉진 시 가벼운 촉진과 깊은 촉진의 목적 (15, 14, 13, 12)



2) 가벼운 촉진 (Light)

- ① 손가락으로 복벽을 가벼운 압력을 가해 누르는데 1cm 이상 누르는 것을 삼가
- ② 근육 저항과 압통 부위를 확인하는 데 사용
- ③ 큰 종괴나 확장된 구조물도 저항을 느낌으로서 확인 가능

3) 심부 촉진 (deep)

- ① 손가락은 펴고 손바닥을 사용하여 깊고 균등하게 복벽 속으로 압력을 가한다.
- ② 가벼운, 중등도 촉진으로 나타나지 않는 통증 발견
- ③ Either one- or two handed technique is acceptable



4) 과민반응과 복부반사 (중요)

① 과민반응(표재성 감각과민증)

② 복부반사

- 반사망치를 이용해 배꼽에서 시작해서 상사분역쪽으로 선을 그어 본다.

- 반사망치의 뒤쪽 이용
- 각각 선을 그었을 때, 복부근육은 수축되고 배꼽은 선을 긋는 방향으로 당겨집니다.



- 가벼운 촉진 시 나타나는 복막 자극 현상
- 종괴 파열, 가스 유무, 장기 파열 + 무엇보다 복막 상태를 알기 위해 함
- 장측복막하고 벽측복막 사이에 복막액이 혼탁해지거나 복막이 염증반응을 일으켜서 고름, 박테리아 有-> 복막 사이가 붓고 장측 복측 벽막이 예민한 상태에서 때면 딱 떨어지면서 통증 유발
- 보통 때면 안 아픈데 이 사람은 눌러도 아프고 땄 때도 아프다 함
- 기침하면 복막이 떨어지면서 울려요 아파요
- 두드릴 때마다 번쩍번쩍
- 걸으라고 하면 다리가 떨어질 때마다 번쩍번쩍 울림
- 질병: 복막 파열이 되는 급성 맹장염, 십이지장염, 위궤양, 외상에 의한 복막 자극, 또는 담낭 쓸개즙에 의한 복막 파열 등
- 청진: 청진음이 감소되거나 안 들림

- 바이탈: 체온 상승, 혈압 하강, 발열, 물이 혈관 밖으로 빠지면서 쇼크가 오기도 함

- lab 소견: CBC, CIP, 라이페이스(효소) 등의 증가

-> 즉 복막 자극 증상과 청진음(장음)의 감소는 외과적 질환 (수술 case이 기도)

Q. 외과적 치료를 암시하는 복통의 진찰소견 (12)

5) 제대

- ① 제대고리와 제대 주위 촉진
- ② 제대고리는 원형이고 규칙적인 모양
- ③ 배꼽테 주변은 돌출되지 않고 덩어리가 만져지지 않아야 한다.
- ④ 중심부가 불완전하거나 부드러우면서 돌출되어 있으면 탈장 시사

6) 간 Q. 간질환에 따른 촉진 시 소견(17, 15, 13) Q. 간의 촉진방법 (12)

A: 간 압통부위 아래 우측 중앙쇄골 부위에서 머리를 향하여 손가락을 편다.

B: 손가락을 늑골연과 평행하게 놓고 하는 간 촉진방법

: 서혜부 ligament가 약해지면 소장이 달려온다. 근육 사이 뚫고 피하로. 배꼽 주위가 취약한 부위라서 그곳으로. (hernia)



7) 간 (대체방법) - 아래 사진 확인

: 지방간(카스텔라처럼 부드러움), 간경변(딱딱한 식빵), 간종양(간경변보다 더 딱딱)



8) 비장

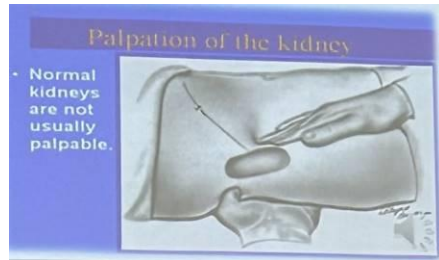
A: 대상자의 좌측 늑척추각 위에 왼손을 놓고 위쪽 방향으로 누른다. 좌측 늑골연 아래에서 오른손으로 비장 촉진

B: 대상자를 옆으로 눕힌 자세에서 비장 촉진하기. 왼손과 오른손가락 끝을 안쪽으로 누른다.



9) 신장

- ① 우측, 좌측 신장 촉진
 - ② 왼손으로 왼쪽 옆구리를 올린 후 오른손으로 깊게 촉진한다.
 - ③ 좌측 신장은 일반적으로 촉진되지 않는다.
- 신장은 아주 말라야하고, 병변 알려고 하는 건 아니고 신우신염이지만 변별



10) 대동맥

- ① 한쪽에서는 손가락의 바닥면으로 대동맥을 향해 깊이 누른다.
- ② 또 다른 쪽에서는 엄지나 반대쪽 손가락을 사용하여 누른다.
- ③ 만약 대동맥이 촉진된다면, 대동맥의 박동을 느낄 수 있습니다.



: 배에서 뭐가 된다고 할 때 대동맥. 한번씩 확인해줘야 하는게 특히 노인이 고혈압이 오래 있으면 박리가 될 수 있는데 괜히 거기다 침 놓고 하다 일 나니까.

11) 복수 평가 Q. 복수의 진찰 방법에 대해 설명하시오 (17, 15, 13)

Q. 복수의 원인 5가지 (14) Q. 복수의 진단 (12)

① 이동성 탁음

- 복수는 중력에 따라 위치
- 반짝거리고 팽팽한 양상(시진)
- 이동성 탁음(Shifting dullness): 액체의 존재를 확인하는 데 도움

- 복수는 여러 질환에서 나올 수 있음: 간, 심장, 영양상태 부족, 암(안 좋은 protein이 물을 끌어당김) 등

- 간경변: 제일 많은 건 경우. 복수가 찬다 = 알부민(혈관 내에서 물을 잡는 역할) 부족 -> 알부민은 간에서 만들어지는데 간염, 간암 등에서 간기능이 시원치 않으니까 안 만들어짐 -> 알부민 농도가 혈관 속에서 낮아지면 물을 놓쳐서 복강 내로

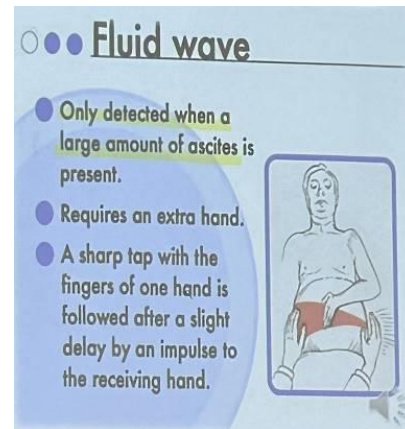
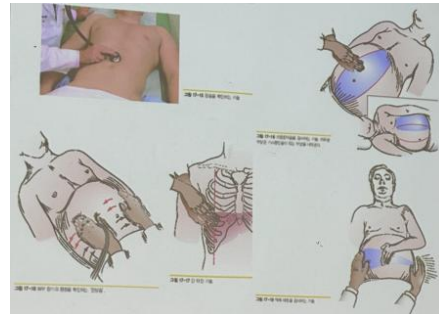
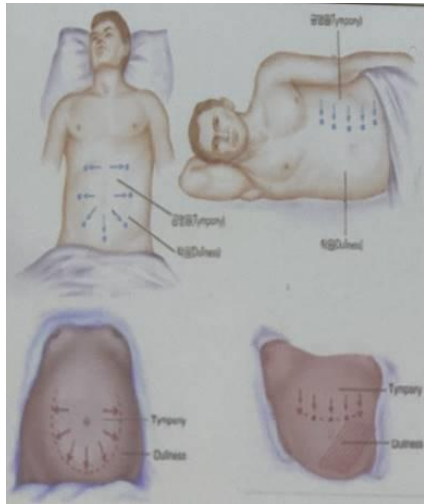
- 심장 문제: pressure가 낮아서 저류

- Cancer: 복강 내 복막에 암 -> 이상물질(주로 protein) -> 그게 물을 잡아당김

- 사실 초음파 쓰면 복수 확인하기 쉬운데, 한의원에서는 그게 힘드니까 이동성 탁음 (자세가 변하면 중력에 따라 탁음 위치가 다르게 들림), 체액 파동 사용

② 체액파동

- 한 손가락 끝으로 복부 한쪽 부위를 예리하게 친다. 다른 손으로 는 체액 파동의 충격을 느낀다.
- 대상자나 다른 사람의 보조 필요
- 체액 파동을 쉽게 느끼면 복수 암시



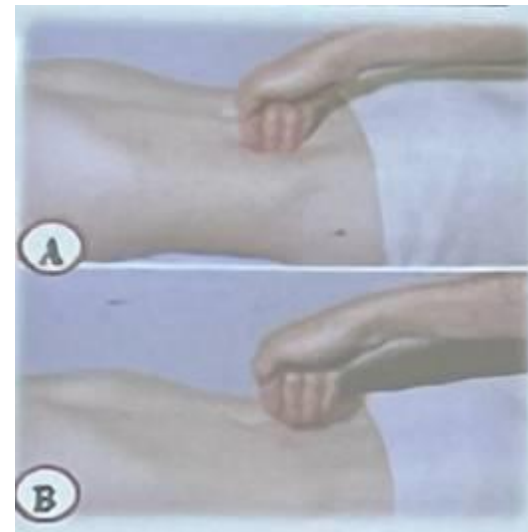
12) 반동압통 (rebound tenderness)

- ① 신체검진의 마지막 단계에서 시행
- ② 복통을 호소하는 대상자에게 복막 자극 유무나 충수돌기염을 판단하는 데 유용하게 이용
- ③ 복막의 염증이 있는 부위에서 칼로 찌르는 듯한 통증 (Blumberg 징후 양성)

A: 배를 깊고 부드럽게 누른다.

B: 손과 손가락은 복벽에서 재빨리 떼낸다.

: 외과적 질환을 요하는 상황



13) 반동압통(rebound tenderness): 충수돌기염(appendicitis)

① Mcburney 징후 양성

② Aaron 징후: Mcburney 부위 촉진시에 대상자의 심장이나 위장 부위에 통증 또는 불쾌감이 나타남

+ Non-Classical Appendicitis

: 장요근 검사(Iliopsoas Sign), 폐쇄근 검사(Obturator Sign)

- 장요근 검사 (iliopsoas muscle test) (아래 좌측 사진)

- 충수돌기염 의심시 시행

- 염증이 측부 장요근의 자극 유발

- 대상자의 다리를 들게 하고 검진자는 반대로 아래쪽으로 누른다.

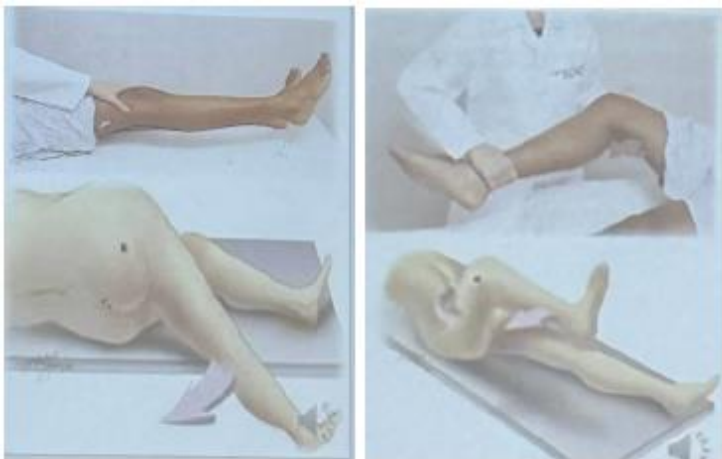
- 좌측위로 눕게 하여 오른쪽 다리를 뒤쪽으로 과신전시키는 방법

- 폐쇄근 검사 (obturator muscle test) (아래 우측 사진)

- 천공성 충수돌기염 또는 골반강 내 농양 의심될 때 시행

- 우측 다리를 고관절과 슬관절에서 굴곡(90도) 시킨 후 다리를 외측과 내측으로 회전

- 통증 유무 확인



<Abdominal pain 복통>

1. 복통이란?

1) 1차 진료에서 가장 흔히 접하는 증상

2) 응급실 전체의 20~30%: 복통으로 내원

2. 복통 부위에 따른 분류 - 1 Q. 복부 4분획에서 발생가능한 질환 (15)

1) RUQ: cholecystitis, hepatitis, duodenal ulcer

2) RLQ: appendicitis, diverticulitis, ectopic pregnancy

3) LUQ: pancreatitis, spleen rupture

4) LLQ: diverticulitis, ectopic pregnancy, constipation

- RUQ: 폐렴(하엽)도

- 게실염은 사실 왼쪽임

- 왼쪽은 별로 중요한 게 없어

- 자궁외 임신 항상 생각해야하므로 생리여부 임신가능성 늘 물어봐야 함

3. 복통 부위에 따른 분류 - 11 Q. 복부 진찰 시 9구획과 주요질환 (13)

1) Epigastrium: gastric ulcer, gastritis, GERD

2) Whole abdomen: panperitonitis(범발성 복막염)

3) Periumbilical: abdominal aneurysm

4) Lower abdomen: PID, ectopic pregnancy

4. 복통의 병태생리

1) 내장성 통증: 내장이나 고형장기의 벽에 있는 신경 말단의 신전에 의해 발생

2) 신체성 통증: 복부 앞면을 덮는 외부 복막에 분포하는 신경 자극에 의해 발생

3) 연관통: 질환이 있는 장기에서 멀리 떨어진 곳에 느껴지는 통증

5. 복통 환자의 임상평가 - 병력

: 위치 / 강도와 성상 / 기간 / 악화 또는 완화 인자 / 동반된 징후, 증상, 상태 / 과거력

: 중요. 97%는 여기서 진단 나오고 3%가 이학적 검사에서 나옴.

6. 복통 환자의 임상평가 - 신체검진

- 1) 활력 징후
- 2) 시진: 안면 표정과 체위를 관찰
- 3) 청진: 장음의 빈도와 크기, 가스의 움직임
- 4) 타진: 중요한 소견을 얻기 힘들
- 5) 촉진: Tenderness/Rebound tenderness (direct / indirect tenderness 라고 함)

7. 복통환자의 임상평가 - Lab

: CBC, LFT, U/A, Amylase/Lipase, HCG, urine HCG

8. 복통 환자의 임상평가 - 방사선 검사

- X-RAY: Intestinal obstruction, Ulcer perforation 진단에 도움
- Abdomen ultrasonogram: Cholecystitis, GB stone, Appendicitis
- Abdomen CT: 염증성 병변, 종양성 병변, 외상성 병변을 진단. Abdominal aortic aneurysm

9. 복통의 치료

- NPO
- IV Hydration
- PRN L-tube insertion
- Pain control
- Analgesics

- Antispasmodics
- narcotic analgesics

: 제일 중요한 것은 일단 굶기는 것 -> 그리고 관찰 + 수액을 충분히 줌

<급성 복통을 일으키는 응급질환>

1. 급성복통을 일으키는 질환 분류 Q. 범발성복막염의 진찰 소견(17, 14, 13)

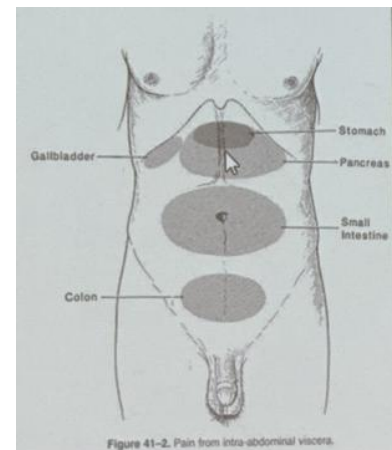
1) 응급 수술이 필요한 질환: panperitonitis, intestinal obstruction ulcer perforation, torsion of bowel

2) 응급 수술은 필요치 않으나 급성복통 형태 질환: acute pancreatitis, acute gastritis acute hepatitis, PID

- 범발성 복막염: 복강내장기, 또는 근접장기나 체표면에서의 세균감염에 의해서 대부분의 복막에 염증이 나오는 것으로 발열, 복통, 구토 복부팽만, 복부전체에 미치는 복수. 백혈구 특히 호중구증가가 나타난다

- ulcer perforation: Ulcer가 시간이 지나면 벽을 뚫고 나와서 위, 십이지장의 음식물 등이 나와서 염증이 생겨서 거기만 아픔.

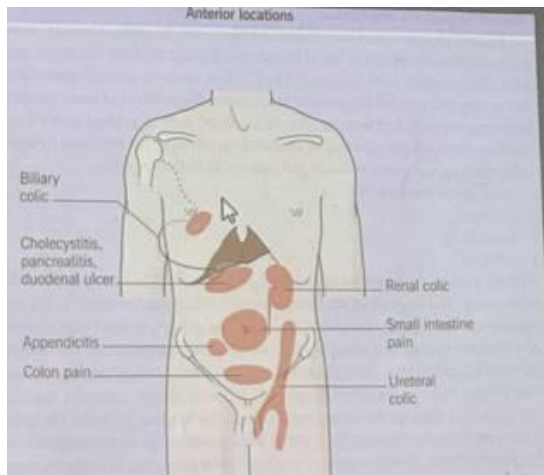
- acute pancreatitis: 응급 수술 필요없는 대표적 질환. 술 엄청 먹고 배 아프다고 먹으면 토하고 다리도 못 피는 등의 증상 (외과적 질환 X)



2. Visceral pain – location Q. 복부질환에서 연관통 통증 부위 기술 (15)

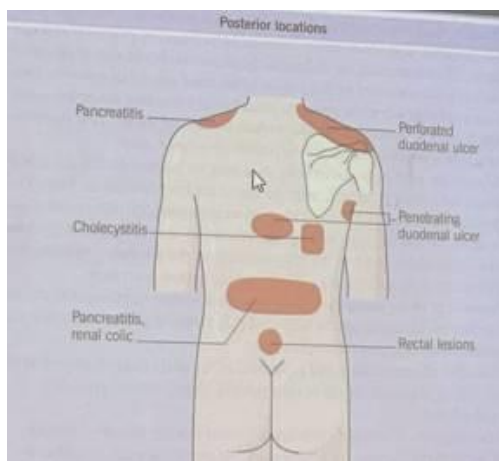
- stomach에서 origin한 pain은 대개 등은 안 아프데, pancreas에서 origin한 경우 등도 같이 아프다.
- 배꼽주위 통증: 대개 소장질환
- 배 전체적 통증: 대장질환

① Location of pain -- anterior



- 서혜부 통증 = 보통 결석. 요로결석 등 (대퇴부 안쪽도 아프다고 함)

② Location of pain – posterior



어깨 아프다고 하는 건 pancreatitis, perforated duodenal ulcer

3. Features of common causes of acute abdominal pain (onset만 읽으심)

- Appendicitis: Hours to days (소화 안되고 울렁거려요. 오른쪽 아랫배 아파요.)
- Cholecystitis: minutes to hours (담도나 담낭 문제. 통증은 관 압력이 높아졌다는 건데 여기 관 자체가 좁기 때문에 금방 아픔)
- Pancreatitis: minutes to hours
- Diverticulitis: Hours to days (밀으로 빠져나온 게실. 거기 음식물이 고여서 문제)
- Perforated peptic ulcer: Minutes (터지자마자 아프기 시작)
- Small bowel obstruction: Hours to days

Condition	Onset	Location	Character	Radiation	Intensity
Appendicitis	Hours to days	Early: periumbilical Late: right lower quadrant	Dull ache	Right lower quadrant	3/5
Cholecystitis	Minutes to hours	Right upper quadrant	Sharp	Scapula	3/5
Pancreatitis	Minutes to hours	Epigastric – back	Boring	Midback	4/5
Diverticulitis	Hours to days	Left lower quadrant	Ache	None	2/5
Perforated peptic ulcer	Minutes	Epigastrium	Sharp/burning	None	5/5
Small bowel obstruction	Hours to days	Periumbilical	Crampy	None	3/5
Mesenteric ischemia/infarction	Minutes	Periumbilical	Agonizing	None	5/5
Ruptured abdominal aortic aneurysm	Minutes	Abdomen, back, flank	Tearing	Back, flank	5/5
Gastroenteritis	Hours to days	Periumbilical	Spasmodic	None	2/5
Pelvic inflammatory disease	Hours to days	Either lower quadrant or pelvis	Ache	Upper thigh	3/5
Ruptured ectopic pregnancy	Minutes	Either lower quadrant or pelvis	Severe	None	3/5

- Mesenteric ischemia/infarction: Minutes
 - Ruptured abdominal aortic aneurysm: Minutes
- (이 뒤쪽으로는 그냥 급하셔서 술술 읽으심)

4. Acute appendicitis Q. 충수돌기염 진단 3가지 징후와 그 방법 (14)**1) Symptoms & Signs**

- ① Pain is begin in the epigastric
- ② then develop to sharp localized pain (RLQ)
- ③ McBurney's point; two-thirds of the line from the navel
- ④ Tenderness/Rebound tenderness
- ⑤ Nausea/Vomiting
- ⑥ Fever

2) Diagnosis

- ① CBC often shows an increased WBC
- ② Abdominal ultrasonogram
- ③ Abdominal CT

3) Treatment

- ① Iv hydration
- ② NPO



③ Antibiotics

④ Operation

★ Typical symptom – appendectomy

Suspected – observation for **4-6hr**

Low possibility – discharge / After 12-24hr resample

외과적 복통 중에 제일 많은 게 급성 충수염

5. Intestinal obstruction**1) Definition**

: Partial or complete blockage of the bowel that results in the failure of the intestinal contents to pass through

2) treatment

: Electrolyte balance, Decompress the intestine, Nasogastric tube insertion,

Operation

★ Mechanical ileus

Paralytic ileus

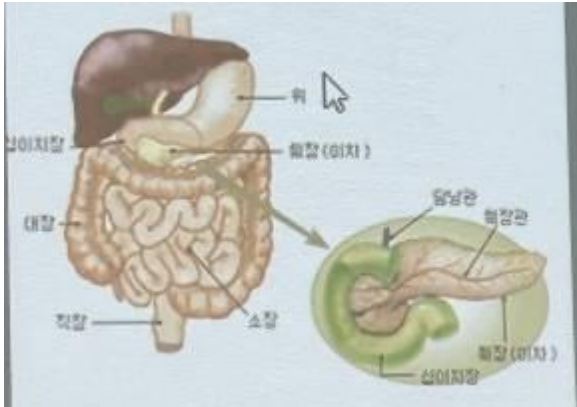


조영시켰는데 일정 부위 이후로 안보인다면 막혔다는 것 -> 바로 처치

6. acute pancreatitis

1) Definition

: inflammation (irritation and swelling with presence of extra immune) of the pancreas



2) Causes & Risk factors: **gallstones, alcohol abuse**

3) Symptoms & Signs

: LUQ pain, nausea / vomiting, sweating, anxiety / fever

상복부 통증, 등도 아프고, 가려움, 술 많이 먹고

4) Diagnosis

- ① Low blood pressure and a heart rate above 90/min
- ② WBC elevated
- ③ A glucose test may show elevated levels
- ④ Elevated serum amylase / serum lipase
- ⑤ Abdominal CT scan / abdominal ultrasound

5) Treatment

- ① To place the pancreas at rest
- ② NPO
- ③ IV Hydration
- ④ Pain control
- ⑤ FOY (gaexate mesylate) medication
- ⑥ Gallstone remove

일단 굶기는 게 우선

7. Abdominal Aortic Aneurysm

1) Definition: abnormal ballooning of the abdominal portion of the aorta

2) Causes & Risk Factors: atherosclerosis and hypertension

3) Diagnosis

: Abdominal X-ray, Abdominal ultrasound, CT scan of abdomen, Angiography of aorta

4) treatment

: Antihypertensive medications, Analgesics to relieve pain, Surgical repair or replacement

8. Acute Cholecystitis

1) Definition: sudden inflammation of the gallbladder

2) Causes & Risk Factors: gallstones

3) Symptoms & Signs

- ① Abdominal pain (RUQ)
- ② Murphy's sign
- ③ Nausea and vomiting
- ④ Fever

4) Diagnosis

: Abdominal ultrasound, Abdominal CT scan, Abdominal X-ray, CBC shows infection by an elevated WBC

9. Acute gastritis

- 1) definition: sudden inflammation of the lining of the stomach
- 2) Causes & Risk factors: medications, alcohol, ingestion of corrosive substances extreme physiological stress, and infections

위염. 음식물이라거나 약물 등으로 위 점막이 훼손.

10. Gastrointestinal Perforation 천공

- 1) Definition: The wall of the stomach, small intestine or large bowel develops a hole through its entire thickness
 - 2) Causes & Risk Factors: appendicitis, diverticulitis, ulcer disease, Crohn's disease
 - 3) Symptoms & Signs: Severe abdominal pain, fevers, nausea, and vomiting
 - 4) Diagnosis: X-rays, CT scan, WBC elevated
 - 5) Treatment
- : Surgery, Colostomy or ileostomy, Antibiotic therapy

>> Check point!

- 식후 즉시 상복부가 조이는 듯한 통증 : 급성 위염
- 공복시 상복부 쓰리다 : 위·십이지장궤양
- 설사·발열·구토 동반 : 급성장염
- 발열·구토·좌상복부 통증, 오른쪽 어깨로 방사통 : 급성담낭염
- 배꼽주위 격통·구토, 등 가운데로 방사통 : 급성 췌장염
- 왼쪽 하복부 혹은 복부 4 변연부 통증 : 대장관련질환
- 옆구리 통증·배뇨통·혈뇨: 신결석·요로결석
- 양쪽 옆구리(여) · 오른쪽 하복통(남·여) : 난관 염증(여) · 맹장(남)
- 하복부 통증· 부정기출혈(여) : 여성생식기질환
- 설사는 대개 내과적 질환
- 외과적으로 처리해야 할 복통: 히스토리, 장음, rebound tenderness, direct tenderness, 기침, 열나면서 lab 소견 등